

Il Corpo Alessitimico — Sintesi

Salute Mentale · Sessione 12

L'alessitimia è l'incapacità di dare un nome alle proprie emozioni. Non è una diagnosi, ma un costrutto che attraversa quasi tutti i quadri clinici del modulo. Vale la pena capirla bene.

La Regolazione Affettiva

- **Regolare le emozioni significa esprimerle in modo congruo al contesto — non reprimerle.**
 - Il bambino impara a regolare le emozioni grazie al **caregiver**, che funge da regolatore esterno fino a quando il bambino non diventa autonomo.
 - Due processi chiave che il bambino deve acquisire:
 - **Verbalizzazione**: dare un nome all'emozione
 - **Desomatizzazione**: capire che la sensazione corporea (tachicardia, calore) segnala un'emozione, non una malattia fisica
 - **Dare un nome all'emozione permette già, in parte, di regolarla — chi non riesce a nominarla non riesce nemmeno a regolarla.**
-

Le 4 Dimensioni dell'Intelligenza Emotiva (Salovey e Mayer)

Da sapere per l'esame — il concetto, non la dicitura esatta:

1. **Percezione, valutazione ed espressione delle emozioni** — riconoscere le proprie emozioni (anche attraverso il corpo) e quelle degli altri
2. **Facilitazione emozionale del pensiero** — usare le emozioni per guidare decisioni e memoria
3. **Comprensione e analisi delle emozioni** — dare etichette verbali, capire emozioni miste e complesse

4. **Regolazione consapevole delle emozioni** — gestire le emozioni in sé e negli altri in modo deliberato

Queste quattro dimensioni corrispondono agli stadi dello sviluppo emozionale: in ordine cronologico dalla prima infanzia all'adolescenza.

Il Costrutto di Alessitimia

Alessitimia — coniato da Peter Sifneos nel 1973. Dal greco: *a* + *lexis* + *thymos* = mancanza di parole per le emozioni. Incapacità di esprimere e riconoscere verbalmente le proprie emozioni.

Caratteristiche principali (Taylor, 1997):

- Difficoltà a discriminare le emozioni tra loro e dalle sensazioni somatiche
- Vocabolario emotivo limitato — difficoltà a comunicarle agli altri
- Attività fantasmatica deficitaria o assente
- Stile cognitivo orientato verso l'esterno, poco introspettivo

Caratteristiche cliniche aggiuntive:

- Conformismo sociale
- Predisposizione all'azione (agiti) piuttosto che all'autoriflessione
- Postura rigida, povertà nell'espressione facciale
- Ridotta empatia
- Scarso ricordo dei sogni (quando li ricordano, contengono violenza)

Le persone alessitimiche *provano* le emozioni — non riescono a collegarle alle sensazioni corporee e a dargli un nome.

Tratto vs Stato

	Alessitimia di tratto	Alessitimia di stato
Origine		

	Alessitimia di tratto	Alessitimia di stato
	Sviluppo emozionale infantile bloccato	Trauma (anche in età adulta)
Stabilità	Stabile, parte della personalità	Potenzialmente reversibile
Intervento	Canali alternativi (musica, arte, teatro)	Elaborazione del trauma

Costrutto Transnosografico

L'alessitimia *non* è una diagnosi — è un costrutto transnosografico: lo si ritrova in quasi tutti i quadri clinici.

Si ritrova in: disturbi psicosomatici · disturbi dell'umore · disturbi d'ansia · dipendenze · disturbi alimentari · disturbi di personalità

Non si ritrova nelle psicosi. Secondo Krystal: il bambino traumatizzato che nega la realtà → psicosi; chi nega la fantasia → alessitimia. Esiti opposti.

Misurazione

- **TAS-20** (Toronto Alexithymia Scale) — 20 item, autovalutazione, scala Likert; la più usata nella ricerca; standardizzata dai 12 anni in su
- **SAR** (Scala Alessitimica Romana) — aggiunge empatia e dimensione somatica
- **TSIA** (Toronto Structured Interview for Alexithymia) — intervista; include fantasia e processi immaginativi

Le scale non fanno diagnosi — sono campanelli d'allarme.

Alessitimia e Trauma

- Secondo Krystal: il trauma blocca i processi di desomatizzazione e verbalizzazione delle emozioni.

- Due cause nel bambino:
 - Il caregiver non regola le emozioni → il bambino raggiunge livelli di intensità intollerabili
 - La disillusione (Winnicott) avviene troppo presto → il bambino non sa più distinguere realtà da fantasia
 - Se l'alessitimia di stato non viene elaborata, si stabilizza nel tempo.
-

Alessitimia e Dipendenze

- Le persone con dipendenza provano affetti in modo indifferenziato e prevalentemente somatico.
 - La sostanza diventa una stampella chimica per regolare (o bloccare) le emozioni.
 - Eziologia multifattoriale, ma il disturbo della regolazione affettiva è centrale.
 - Cruise e Becerra (2018): l'alessitimia è fattore di rischio indipendente per il consumo problematico di alcol.
 - Molti pazienti con dipendenza mostrano **attaccamento insicuro** nell'infanzia (Krystal, Khantzian).
-

Da ricordare:

- **Alessitimia** = mancanza di parole per le emozioni. Non è una diagnosi, è un costrutto transnosografico.
- **Tratto vs stato** = sviluppo bloccato vs conseguenza di trauma. Diversi interventi.
- **Non nelle psicosi** — unica eccezione al transnosografico.